

Skuteczność STPP

Wbrew mitowi o „braku badań” STPP ma solidną bazę dowodową: meta-analizy 160+ badań z randomizacją, duże wielkości efektu, skuteczność porównywalna z terapią poznawczą i trwałość efektów po zakończeniu.

CZAS: 20 min Pacjent pytający o dowody; argumentacja przed komisją

ŹRÓDŁO: Shedler (2010); Abbass i in. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Odpowiadasz konkretnie na pytanie „czy to działa?": meta-analizy ponad 160 badań z randomizacją (ang. *RCT*) pokazują duże wielkości efektu ($d = 0,7-0,9$), porównywalne z terapią poznawczą. Wskazujesz wariant z najsilniejszymi dowodami dla problemu pacjenta (depresja → DIT; somatyzacja → ISTDP; zaburzenia osobowości → terapia długoterminowa) i jesteś uczciwy/-a co do ograniczeń metodologicznych.

DLACZEGO TO DZIAŁA

STPP wyróżnia **efekt opóźniony** (ang. *sleeper effect*): efekty rosną po zakończeniu terapii, w odróżnieniu od części interwencji poznawczych, gdzie się stabilizują lub słabną. Interpretacja: STPP pracuje na mechanizmach — wzorzec relacyjny, afekt, wgląd — które działają dalej po sesjach. Psychoterapia psychodynamiczna trudniej poddaje się randomizacji niż terapia poznawcza, co długo utrudniało gromadzenie dowodów, ale zmieniło się to po 2005 r.

01



Pięć filarów bazy dowodowej

- ① **Shedler (2010)** — przegląd 160 badań; duże wielkości efektu, także dla zaburzeń osobowości
- ② **Leichenring i Rabung (2008)** — terapia długoterminowa w zaburzeniach złożonych
- ③ **Abbass i in. (2014, Cochrane)** — przewaga nad leczeniem standardowym (ang. *TAU*); utrzymanie efektów
- ④ **Fonagy i in. (2015)** — długoterminowa STPP w opornej depresji: większa remisja
- ⑤ **Steinert i in. (2017)** — równoważność STPP i terapii poznawczej w depresji

02



Gdy pacjent porównuje z terapią poznawczą

„Oba podejścia działają. STPP jest nieco lepsza w długiej obserwacji po zakończeniu (efekt opóźniony), terapia poznawcza w szybkiej redukcji ostrych objawów. Wybór zależy od celu.” Nie wchodzi w spór „która lepsza”.

JAK UJMĘ TO WOBEC TEGO PACJENTA

03 🎯 Najsilniejsze dowody dla problemu pacjenta

Dobierz argument do konkretnej diagnozy — to wzmacnia wiarygodność i nadzieję pacjenta.

Depresja → **DIT** (Fonagy)

Somatyzacja → **ISTDP** (Abbass)

Zaburzenia osobowości → **terapia długoterminowa**
(Leichsenring)

Lęk uogólniony → **STPP** (meta-analizy)

04 💡 Wskaż mechanizmy, nie tylko wynik

„Nie tylko 'czy działa' — ale jak. STPP pracuje z wzorcem relacyjnym, afektem i wglądem. To tłumaczy efekt opóźniony.” Zapisz, które mechanizmy są najważniejsze dla tego pacjenta.

MECHANIZMY ISTOTNE DLA TEGO PRZYPADKU

Klucz: nie wchodzić w spór „terapia poznawcza vs STPP”. Obie są oparte na dowodach, działają różnymi mechanizmami, dla różnych pacjentów lub różnych faz tego samego pacjenta. Dojrzały terapeuta zna obie i wybiera świadomie.